



« SUIVI BIOLOGIQUE DES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS ORAUX DIRECTS EN ALGERIE : EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX RECOMMANDATIONS »



CHELLIL Maroua¹, BOUNAAS SARRA², BOUHEDADJA Zahia¹

Affiliation : ¹laboratoire de pharmacologie, département de pharmacie, faculté de médecine, université Ferhat Abbas -Sétif 1

² laboratoires d'hémodiologie et transfusion sanguine, CHU Saadna Abdenour - Sétif

Chellil.ma24@gmail.com

INTRODUCTION

La prise en charge de la maladie thromboembolique reposait traditionnellement sur les héparines et les antagonistes de la vitamine K, mais la recherche d'un anticoagulant plus efficace et plus sûr a conduit au développement des anticoagulants oraux directs (AOD), dont le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban et l'edoxaban. Grâce à leur administration orale, leur pharmacocinétique prévisible et l'absence de surveillance biologique systématique, les AOD se rapprochent du profil de l'anticoagulant idéal.

RÉSULTATS

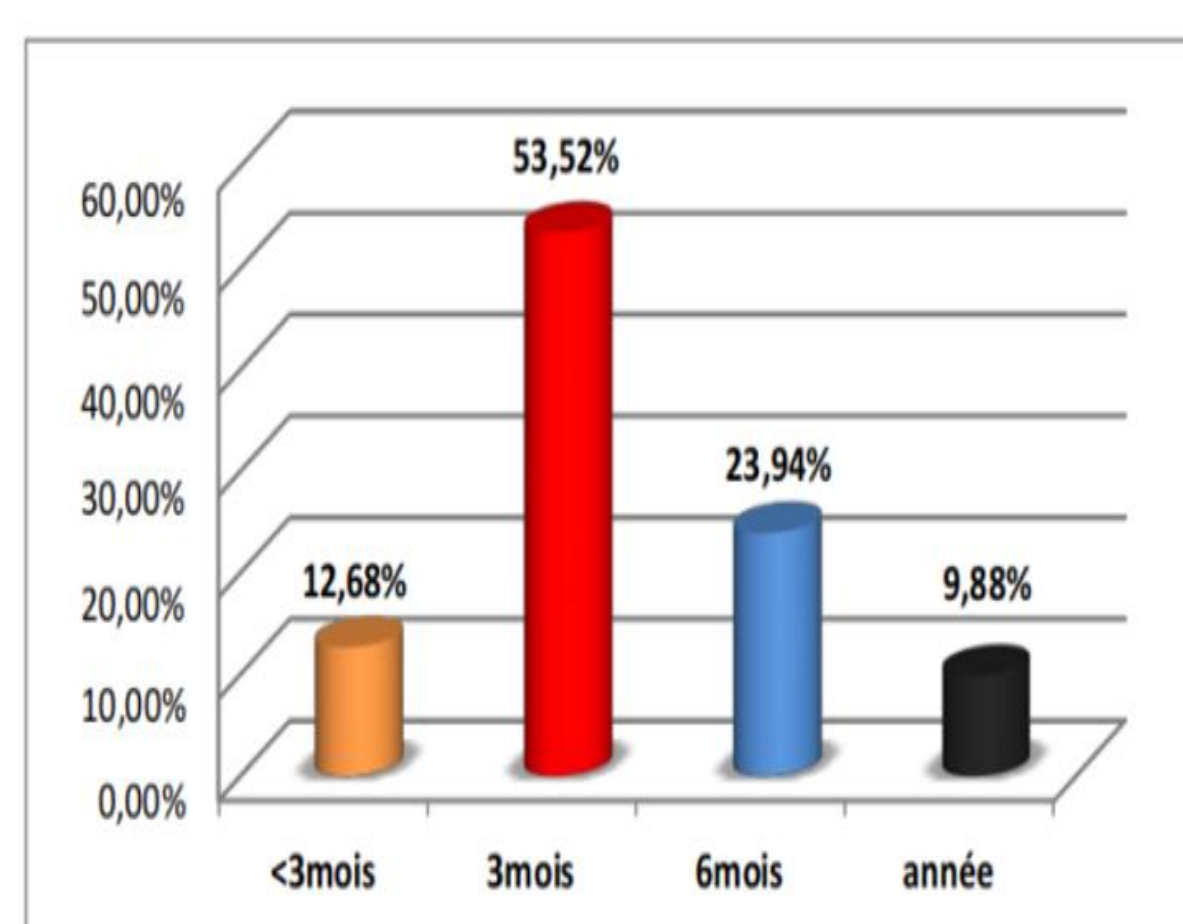


Figure 1: Le rythme de contrôle biologique des patients sous AOD

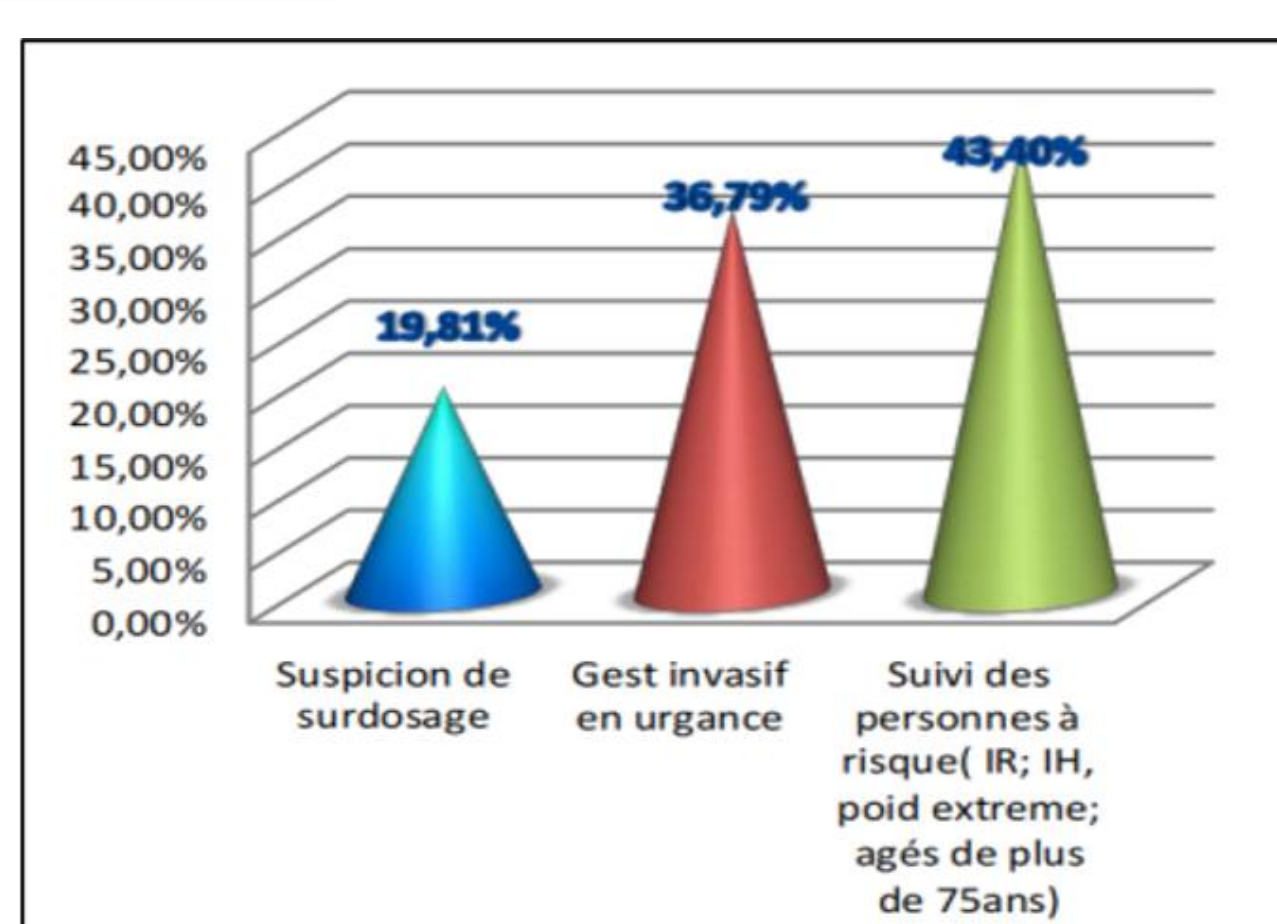


Figure 2: Répartition par situation qui nécessite un suivi biologique selon les médecins,

Bilan rénal seul	8.07 %
Bilan d'hémostase seul	1.61 %
Bilan rénal + hépatique	1.61 %
Bilan rénal + NFS	1.61 %
Bilan rénal + bilan d'hémostase	11.30 %
Bilan hépatique + bilan d'hémostase	1.61 %
Bilan d'hémostase + NFS	3.23 %
Bilan rénal + hépatique + NFS	16.12 %
Bilan rénal + d'hémostase + NFS	8.07 %
Bilan rénal + hépatique + hémostase	8.07 %
Bilan hépatique + d'hémostase + NFS	1.61 %
Bilan rénal + hépatique+d'hémostase+NFS	37.09 %

Tableau 1: Le type de bilan demandé par les médecins et leur pourcentage.

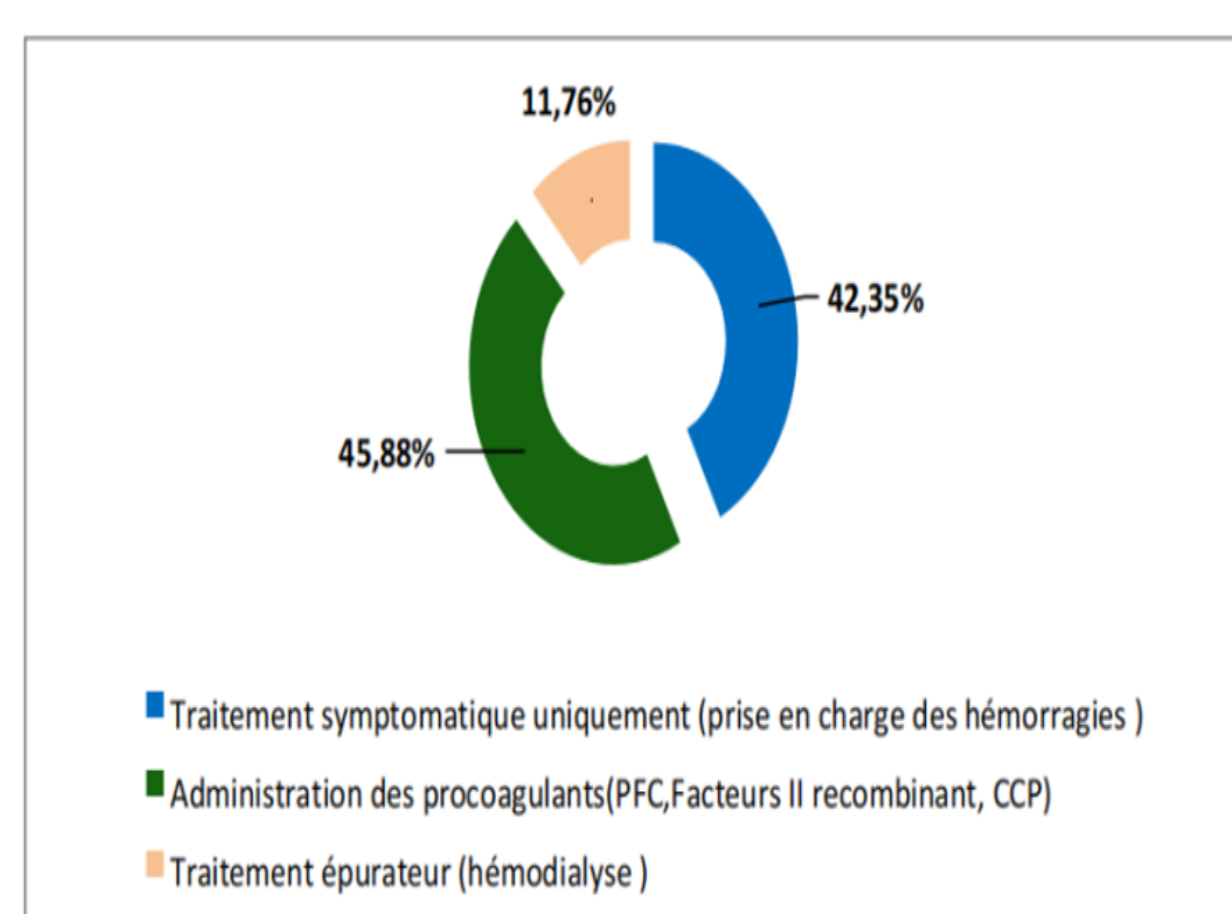


Figure 3: Les conduites à tenir en cas de surdosage de l'AOD

CONCLUSION

Les anticoagulants oraux directs (AOD) représentent une avancée thérapeutique importante dans la prise en charge de la maladie thromboembolique. Cependant, leur utilisation reste limitée par certaines difficultés, notamment la gestion du risque hémorragique, l'absence de tests spécifiques de surveillance et la disponibilité restreinte des antidotes. Notre étude a mis en évidence des insuffisances dans l'application des recommandations de suivi biologique, soulignant la nécessité de renforcer la formation des prescripteurs afin d'optimiser l'utilisation des AOD en pratique courante.

REFERENCES

- 1- Ten Cate H. New oral anticoagulants: Discussion on suivi and adherence should start now! Thromb J 2013; 11:8.
- 2- D.M. SMADJA. Gestion des accidents hémorragiques sous AOD. Réalités cardiologiques (302) - Septembre 2014.
- 3- Pernod C, Albaladejod P graves et de la chirurgie en urgence chez les patients recevant un anticoagulant, prise en charge des complications hémorragiques orales.Proposition du groupe d'intérêt en hémostase péri-opératoire (GIHP)-mars 2013.
- 4- Centre National Hospitalier d'Information sur le Médicament. Thériaque [Internet]. [Cité 2015 avr 9].Available from: <http://www.theriaque.org>
- 5- Lee Lai Heng. Laboratory monitoring of oral anticoagulants.
- 6- V. Derlon,G.Corbannois,M.Martin,M.Toussaint-Hacquard,G.Audibert.Hémorragies cérébrales et nouveaux anticoagulants. Service d'anesthésie réanimation, CHU de Brabois,France.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Nous avons procédé à une étude transversale déclarative menée auprès des médecins **spécialistes** hospitaliers et libéraux (cardiologues, internistes et orthopédistes) dans les wilayas de : Sétif, M'ssila, Bordj Bou Arreridj, Alger et Boumerdes) à l'aide d'un questionnaire. Pour optimiser la participation, le questionnaire est rempli anonymement et rédigé sous deux formes de contenu identique :Une version papier et Une version électronique afin de permettre une meilleure participation. La version papier a été rédigé à l'aide du logiciel Microsoft Word 2007, la version électronique été rédigée via Google Drive. Le recueil et l'analyse des résultats a été fait par Excel. L'objectif était d'évaluer la conformité du suivi biologique des patients sous AOD par rapport aux recommandations.

DISCUSSION

L'étude met en évidence une méconnaissance importante des recommandations concernant la surveillance et la gestion des anticoagulants oraux directs (AOD) chez les médecins prescripteurs.

Suivi biologique de l'activité anticoagulante : 82 % des médecins ignorent les situations nécessitant cette surveillance. Seuls **36,79 %** savent qu'elle peut être utile avant un geste invasif urgent, et **19,81 %** en cas de suspicion de surdosage. Bien que la surveillance systématique des AOD ne soit généralement pas recommandée, certaines situations particulières ou urgentes peuvent justifier l'évaluation de l'effet anticoagulant.

Bilans avant prescription : 71 % des médecins demandent un bilan complet (fonction rénale, hépatique, hémostase et NFS) avant de prescrire un AOD. Or, la HAS recommande principalement l'évaluation de la fonction rénale, de la fonction hépatique et du taux d'hémoglobine. Aucun médecin n'a mentionné la mesure de l'activité anti-Xa, probablement en raison de son indisponibilité dans les laboratoires, bien que **98,61 %** souhaitent y avoir accès.

Rythme de surveillance biologique : La majorité des médecins (**53 %**) réalisent un contrôle tous les trois mois, alors que la HAS réserve ce rythme aux patients présentant une clairance de la créatinine inférieure à 30 mL/min. Les recommandations prévoient généralement un suivi annuel, avec une surveillance plus rapprochée selon l'âge ou la fonction rénale.

Conduite à tenir en cas de surdosage : L'absence d'antidote spécifique pour certains AOD reste une source d'inquiétude. En cas de surdosage, **46 %** des médecins privilégient les procoagulants, **42 %** un traitement symptomatique et **11,76 %** l'hémodialyse. Selon la HAS, la prise en charge repose principalement sur des traitements symptomatiques, avec recours possible à des concentrés de facteurs de coagulation ou à la dialyse pour le dabigatran.